

Раздел 3. Иммунологическая память. Аллергические реакции.

Аутоиммунные заболевания и иммунодефициты. Иммунопрофилактика.

Иммунологическая память – это: {

- = способность к быстрому и эффективному ответу при повторном воздействии антигена
 - ~ неадекватно высокая реакция на повторное воздействие антигена
 - ~ слабо выраженная реакция на повторное воздействие антигена
 - ~ отсутствие реакции на повторное воздействие антигена
 - ~ формирование аутоиммунной реакции на повторное воздействие антигена.
- }

В процессе формирования иммунологической памяти осуществляется: {

- ~ выработка аллергических антител класса E
 - ~ выработка аутоиммунных антител
 - = дифференцировка Т- и В-лимфоцитов в клетки памяти
 - ~ минимальная продукция антител
 - ~ формирование иммунных комплексов.
- }

Лимфоциты памяти: {

- ~ 33,33333% могут начать иммунный ответ вне воспаления
 - ~ 33,33333% меньше нуждаются в медиаторах доиммунного воспаления
 - ~ 33,33333% меньше нуждаются в костимулирующих сигналах
 - ~ 50% имеют большие размеры
 - ~ 50% обнаруживаются только в центральных органах иммунной системы
- }

Антителообразование в процессе формирования иммунологической памяти включает следующие фазы: {

- ~ иммуногенная
 - ~ патофизиологическая
 - = логарифмическая
 - ~ продромальная
 - ~ отмирания.
- }

Т-лимфоциты памяти: {

- = обеспечивают эффективный ответ на повторное введение антигена
 - ~ из тканей повторно мигрируют в тимус
 - ~ длительно в организме не сохраняются
 - ~ обнаруживаются в центральных органах лимфоидной системы.
 - ~ являются гранулоцитами.
- }

В-лимфоциты памяти: {

- ~ 33,33333% отличаются долголетием
 - ~ 33,33333% отличаются способностью быстро отвечать на повторное введение антигена
 - ~ 33,33333% синтезируют преимущественно антитела класса G
 - ~ 50% не накапливаются в периферических органах иммунной системы
 - ~ 50% неустойчивы к апоптозу.
- }

Иммунный ответ развивается в следующих фазах: {

- ~%-50%иммуногенная
- ~ %33,33333%индуктивная
- ~%33,33333%логарифмическая
- ~%33,33333%стационарная
- ~%-50% иммунопатологическая.

}

Лимфоциты памяти: {

- ~%33,33333%сохраняют рецепторы к антигенам
- ~%33,33333%обладают «активным» геном, препятствующим апоптозу
- ~%33,33333%имеют хоминговые рецепторы
- ~%-50%иммунный ответ начинают только при максимальных антигенных воздействиях
- ~%-50%недолгоживущие.

}

Иммунный статус человека – это: {

- = количественные и функциональные характеристики, определяющие иммунный ответ
- ~индивидуальная устойчивость к инфекционным заболеваниям
- ~динамика изменения конкретного показателя иммунитета в течение определённого времени
- ~устойчивость к инфекционным заболеваниям, передающаяся по наследству
- ~устойчивость к инфекционным заболеваниям после плановой вакцинации.

}

Причины развития первичных иммунодефицитов: {

- ~недостаточность питания
- ~ рентгеновское облучение
- ~хронические рецидивирующие инфекции
- = генетические нарушения
- ~профессиональные вредности.

}

Вторичные иммунодефициты клинически проявляются: {

- ~с первых дней жизни
- ~с 4-6 месяца жизни
- ~с двух лет
- ~в пожилом возрасте
- = независимо от возраста.

}

Иммунорегуляторный индекс – это: {

- ~соотношение Т-лимфоцитов и В-лимфоцитов
- ~абсолютное количество В-лимфоцитов
- ~ абсолютное количество Т-лимфоцитов
- = соотношение Т-хелперов и Т-киллеров
- ~соотношение нейтрофилов и макрофагов.

}

Вирус, вызывающий СПИД у человека относят: {
~к РНК-содержащим ротавирусам
~к РНК-содержащим пикорнавирусам
= к РНК-содержащим лентивирусам
~ к ДНК-содержащим гепаднавирусам
~к ДНК-содержащим вирусам герпетической группы.
}

ВИЧ передаётся: {
~воздушно-капельным путём
~алиментарным путём
=парентеральным
~трансмиссивным
~бытовым.
}

Фермент ВИЧ, необходимый для встраивания в ДНК клетки-хозяина: {
~ РНК-аза
~ДНК-полимераза
~гиалуронидаза
= интегразы
~протеаза ВИЧ-1.
}

Клетками-мишенями вируса иммунодефицита человека не являются: {
~Т-лимфоциты
~В-лимфоциты
~макрофаги
~стволовые кроветворные клетки
= эритроциты.
}

Клинические проявления дефицита системы комплемента включают: {
~ лимфопролиферативный синдром
~ аутоиммунный синдром
= инфекционный синдром
~ аллергический синдром
~ геморрагический синдром.
}

Проявлениями I типа аллергических реакций в стоматологии являются: {
~%-33,33333%болезнь Бехчета
~%-33,33333%синдром Шёгрена
~%50%анафилактический шок
~%50%отёк Квинке
~%-33,33333%пародонтит.
}

Индикаторной болезнью при ВИЧ-инфекции может быть: {
~%-33,33333%анафилактический шок
~%50%токсоплазмоз
~%50%пневмоцистная пневмония
~%-33,33333% крапивница
~%-33,33333%бронхиальная астма.
}

Для рецидивирующего афтозного стоматита характерно: {
~%33,33333%экспрессия Эп-антигена
~%-50%формирование иммунодефицита
~%33,33333%очаги изъязвления слизистой оболочки полости рта
~%33,33333%хроническое течение
~%-50%геморрагический синдром.
}

К IV типу аллергических реакций относится: {
~герпетическая полиморфная эритема
=лекарственный стоматит
~синдром Шёгрена
~рецидивирующий афтозный стоматит
~отёк Квинке.
}

Афтозный стоматит характеризуется: {
~%-50%развитием I типа аллергических реакций
~33,33333%формированием комплекса Ig-G/Ig-M
~33,33333%активацией комплемента
~33,33333%хроническим течением
~%-50%поражением слюнных желёз.
}

Вирус, вызывающий СПИД у человека относят: {
~к ортомиксовирусам
~к РНК-содержащим пикорнавирусам
=к РНК-содержащим ретровирусам
~к ДНК-содержащим поксвирусам
~к РНК-содержащим флавивирусам.
}

ВИЧ передаётся: {
~%-33,33333%трансмиссивным путём
~%-33,33333%воздушно-капельным путём
~%-33,33333%алиментарным путём
~%50%перкутантным путём
~%50%половым.
}

Болезнь Бехчета характеризуется развитием: {
~%50%грибковых пневмоний
~%50%фолликулитов
~%33,33333%мультисистемных васкулитов
~%33,33333%рекуррентных язвенных процессов в области гениталий
~%33,33333%рекуррентных язвенных процессов в полости рта.
}

Иммунодефициты, имеющие проявления в стоматологии: {
~%50%ВИЧ-инфекция
~%-33333%Синдром Луи-Бар
~%-33,33333%Синдром Стивена-Джонсона
~%50%Ди-Джорджи
~%-33,33333%Чёрджа-Стросса.
}

Фермент ВИЧ, необходимый для встраивания в ДНК клетки-хозяина: {
~нейраминидаза
~аланинаминотрансфераза
~ДНК-полимераза
=интеграза
~протеаза ВИЧ-1.
}

Проявлениями ВИЧ-инфекции в полости рта являются: {
~сиалоадениит
~афтозный стоматит
=генерализированный пародонтит
~опухоли десны
~геморрагический васкулит.
}

Клинические проявления дефицита системы комплемента включают: {
~аутоиммунный токсический зоб
=инфекционный синдром
~синдром Шёгрена
~геморрагический синдром.
~тромбоцитопению.
}

Для синдрома Ди-Джорджи характерно: {
~%50%снижение количества лимфоцитов CD 4+
~%-33,33333%повышение количества В-лимфоцитов
~%-33,33333%снижение количества макрофагов
~%-33,33333%снижение количества эритроцитов.
~%50%вариабельное количество В-лимфоцитов..
}

Клинические проявления болезни Бехчета: {
~%-33,33333%геморрагический синдром
~%-33,33333%пневмоцистные пневмонии
~%50%воспаление синовиальных оболочек
~%-33,33333%фурункулёз
~%50%увеит.
}

СПИД у человека вызывается: {
=РНК-содержащим ретровирусом
~вирусом Т-клеточного лейкоза человека типов 1,2
~цитомегаловирусом
~ротавирусом
~вирусом Эпштейна-Барр.
}

Вирус иммунодефицита человека не передаётся: {
~при парентеральном введении крови и её продуктов
~при слизистых контактах
~при трансплантации
~при грудном вскармливании
= через неповреждённую кожу.
}

Клеточная латентность при инфицировании вирусом иммунодефицита человека: {
~отсутствие РНК вируса в клетке
~наличие РНК вируса в клетке
~наличие провирусной ДНК в цитоплазме клетки
= интеграция провирусной ДНК в ДНК клетки
~отсутствие провирусной ДНК в цитоплазме клетки.
}

Динамическое исследование антител к вирусу иммунодефицита человека после
возможного заражения проводят одновременно с определением маркёров заболеваний,
передаваемых половым путем в течение: {
~одного месяца
~трёх месяцев
~шести месяцев
=в течение одного года
~в течение двух лет.
}

Проявлением вторичного иммунодефицита может быть: {
~острые вирусные инфекции
~ атопический дерматит
= рецидивирующие инфекционные заболевания
~сердечно-сосудистые заболевания
~сывороточная болезнь.
}

Симптомами иммунодефицитного состояния у детей могут быть: {
~%33,33333%нарушение развития лицевого черепа
~%33,33333%упорная молочница у детей старше одного года
~%-50%эпилептические припадки
~%33,33333%недоразвитие или отсутствие лимфоузлов, миндалин
~%-50%карликовый рост.
}

При внутриутробной инфицированности плода отмечается преимущественный синтез: {
~Ig A
~Ig E
= Ig M
~Ig G
~зависит от вида инфекции.
}

Проявлениями I типа аллергических реакций в стоматологии являются: {
~%-50%поллиноз
~ %33,33333%анафилактический шок
~%33,33333%отёк Квинке
~%33,33333%синдром Лайелла
~%-50%синдром Стивена-Джонсона.
}

ВИЧ-инфекция может сопровождаться развитием: {
~%33,33333%саркомы Капоши
~%33,33333%криптококкоза лёгких
~%-50%ревматоидного артрита
~%33,33333%пневмоцистной пневмонии
~%-50%атопического дерматита.
}

К IV типу аллергических реакций относится: {
~поллиноз
~ревматоидный артрит
~системная красная волчанка
=контактный дерматит
~отёк Квинке.
}

Ig-E-опосредованные реакции чаще развиваются на следующие препараты: {
~%33,33333% антибиотики группы β -лактамов
~%33,33333%продукты крови
~%33,33333%блокаторы нервно-мышечной передачи
~%-50%кортикостероиды
~%-50%антигистаминные средства.
}

Толерантность иммунной системы беременной женщины к антигенам плода обусловлена: {
~позитивной селекцией лимфоцитов у плода
~негативной селекцией аутореактивных клонов лимфоцитов у плода
~отсутствием у плода чужеродных антигенов
~снижением активности Т-лимфоцитов у беременной женщины
= очень низкой концентрацией антигенов гистосовместимости на трофобласте.
}

Иммунорегуляторный индекс в период беременности: {
=снижается
~повышается
~не изменяется
~зависит от течения беременности
~изменяется в разные сроки беременности
}

Адьюванты: {
~имеют белковую природу
~не активируют лимфоциты
~не вызывают аллергические реакции
= непосредственно активируют клетки доиммунного воспаления
~оказывают литическое действие на бактерии.
}

При лечении агаммаглобулинемии Брутона целесообразно назначение: {
~эритроцитарной массы
~препаратов тимуса
= гипериммунного гамма-глобулина
~гамма-интерферона
~кортикостероидных препаратов.
}

При лечении иммунодефицита с дефектом фагоцитоза возможно применение: {
~гамма-глобулина
~препаратов тимуса
~эритроцитарной массы
= лейкоцитарной массы
~ адаптогенов.
}

Антигеном ВИЧ, вызывающим поликлональную активацию В-лимфоцитов, является: {
~gp-41
~gp-24
~p-7
= gp-120
~h-6.
}

Высокий риск ВИЧ-инфицирования ребёнка возникает: {
= при грудном вскармливании
~ при тесном контакте
~ при передаче вируса воздушно-капельным путём
~ через неповреждённую кожу
~ при укусах насекомых.
}

Клинические стадии инфицирования вирусом иммунодефицита человека классифицируют: {
~%50% по манифестации индикаторных заболеваний
~%50% по числу Т-лейкоцитов фенотипа CD-4+
~%-33,33333% по числу В-лимфоцитов и NK-клеток
~%-33,33333% по числу нейтрофилов
~%-33,33333% по результатам общего анализа крови.
}

Для синдрома Ди-Джорджи характерны: {
~%-50% экземы
~%33,33333% пороки сердца
~%33,33333% гипоплазия тимуса
~%33,33333% аномалии лицевого скелета
~%-50% увеличение щитовидной железы.
}

Первичные дефекты фагоцитоза проявляются после перенесённых: {
~ вирусных инфекций
= бактериальных инфекций
~ паразитарных инфекций
~ грибковых инфекций
~ глистных инвазий.
}

Болезнь Брутона обусловлена: {
~ Т-клеточной недостаточностью
~ комбинированной Т и В-клеточной недостаточностью
~ дефектом системы фагоцитоза
= В-клеточной недостаточностью
~ дефектом системы комплемента.
}

Развитие синдрома Шёгрена может быть обусловлено {
~ предшествующей травмой
= предшествующей вирусной инфекцией
~ тромбоцитопенией
~ аллергической реакцией I типа
~ нейтропенией.
}

Высокая восприимчивость к кандидозной инфекции полости рта отмечается: {
~в молодом возрасте
~у подростков
= у грудных детей
~ у пожилых
~от возраста не зависит.
}

Синдром Ди-Джорджи обусловлен: {
~В-клеточной недостаточностью
=Т-клеточной недостаточностью
~комбинированной В и Т-клеточной недостаточностью
~дефектом системы фагоцитоза
~дефектом системы комплемента.
}

В результате инфицирования вирусом клеток CD-4+ происходит: {
~гибель клетки
=латентная инфицированность клетки
~образование симпластов
~пролиферация клеток
~гиперпродукция цитокинов.
}

Свойства антигенов вирус-индуцированных опухолей: {
~%-33,33333%отличаются во всех опухолях и тканях в зависимости от их гистогенеза
~%-33,33333%могут быть внутриклеточными
~%-50%могут экспрессироваться на мембранах клеток опухоли
~%-50%идентичны во всех опухолях
~%-33,33333%изменяются в процессе роста опухоли
}

Раково-эмбриональными антигенами являются: {
~%-33,33333%простатспецифический антиген (PSA)
~%-50%альфа –фетопротеин
~%-50%бета-хорионический гонадотропин
~%-33,33333%белок Р-53
~%-33,33333%антиген HBS.
}

Саркома Капоши: {
~%-33,33333%вызывается вирусом герпеса типа 8
~%-33,33333%является результатом пролиферации клеток лимфоэндотелиального происхождения
~%-50%её рост ингибируется белком ВИЧ
~%-33,33333% характеризуется поражением лимфатических узлов
~%-50%является индикаторной болезнью синдрома Ди-Джорджи.
}

Проявлениями вторичных иммунодефицитов могут быть: {

- ~%-50%острые вирусные инфекции
 - ~%33,33333%опухолевые заболевания
 - ~%33,33333%рецидивирующие инфекционные заболевания
 - ~%-50%сердечно-сосудистые заболевания
 - ~%33,33333%аутоиммунные заболевания.
- }

Клинические проявления синдрома Ди-Джорджи: {

- ~%-50%анемия
 - ~%33,33333%тетрада Фалло
 - ~%33,33333%аномалии лицевого скелета
 - ~%33,33333%судороги
 - ~%-50%желтушность кожи.
- }

Для синдрома Шёгрена характерно: {

- ~%-50%экзема
 - ~%33,33333%сухой кератоконъюнктивит
 - ~%33,33333%прогрессирующий кариес зубов
 - ~%33,33333%лимфоцитарная инфильтрация слюнных желёз
 - ~%-50%тремор верхних конечностей.
- }

Симптомами иммунодефицитного состояния у детей могут быть: {

- ~%-33,33333%боли в суставах
 - ~%50%упорная молочница у детей старше одного года
 - ~%50%упорная геморрагическая диарея
 - ~%-33,33333%острые вирусные инфекции
 - ~%-33,33333%диабет I типа.
- }

При лечении агаммаглобулинемии Брутона целесообразно назначение: {

- ~%-33,33333%лейкоцитарной массы
 - ~%-33,33333%антибиотиков
 - ~%50%гипериммунного гамма-глобулина
 - ~%50%гамма-глобулина
 - ~%-33,33333%переливание цельной крови.
- }

При лечении иммунодефицита с дефектом фагоцитоза возможно применение: {

- ~гамма-глобулина
 - ~препаратов тимуса
 - ~эритроцитарной массы
 - =лейкоцитарной массы
 - ~ кортикостероидных препаратов.
- }

При X-сцепленных агаммаглобулинемиях типа Брутона развиваются заболевания: {
~ эндокринные
~ аутоиммунные
~ аллергические
= бактериальные
~ лимфопролиферативные.
}

Заболевания, развивающиеся при первичных Т-клеточных иммунодефицитах: {
= вирусные
~ грибковые
~ протозойные
~ бактериальные
~ глистные инвазии.
}

Первичные дефекты фагоцитоза проявляются: {
= с первых дней жизни
~ с 4-6 месяца жизни
~ на втором году жизни
~ в подростковом возрасте
~ в зрелом возрасте.
}

Для синдрома Вискотта-Олдрича характерны: {
~ рецидивирующие инфекции
= тромбоцитопении
~ бронхиальная астма
~ пороки сердца
~ аномалии развития конечностей.
}

Укажите заболевания, возможные в первой стадии инфицирования ВИЧ: {
~ лимфома мозга
~ грибковые поражения кожи и слизистых оболочек
= лимфаденопатия
~ саркома Капоши
~ экзема кожи.
}

При X-сцепленных агаммаглобулинемиях типа Брутона развиваются инфекционные заболевания: {
~ с 1 – 2 месяца жизни
= с 4 – 6 месяца жизни
~ на втором году жизни
~ в подростковом возрасте
~ в разное время.
}

Болезнь Брутона обусловлена: {
~ Т-клеточной недостаточностью
~ комбинированной Т и В-клеточной недостаточностью
~ дефектом системы фагоцитоза
= В-клеточной недостаточностью
~ дефектом системы комплемента.
}

Синдром Ди-Джорджи обусловлен: {
~ В-клеточной недостаточностью
= Т-клеточной недостаточностью
~ комбинированной В и Т-клеточной недостаточностью
~ дефектом системы фагоцитоза
~ дефектом системы комплемента.
}

В результате инфицирования вирусом клеток CD-4+ происходит: {
~ мутация ДНК клетки
= латентная инфицированность клетки
~ образование симпластов
~ пролиферация клеток
~ гиперпродукция цитокинов.
}

Свойства антигенов вирус-индуцированных опухолей: {
~ отличаются во всех опухолях и тканях в зависимости от их гистогенеза
~ могут быть внутриклеточными
~ не могут экспрессироваться на мембранах клеток опухоли
= идентичны во всех опухолях
~ изменяются в процессе роста опухоли.
}

Раково-эмбриональными антигенами являются: {
~ простатспецифический антиген (PSA)
= хорионический гонадотропин
~ SCC
~ CA-125
~ CA-19-9.
}

Аутоиммунными заболеваниями чаще страдают: {
~ подростки
= женщины репродуктивного возраста
~ мужчины
~ новорождённые
~ только лица преклонного возраста.
}

Феномен гиперчувствительности замедленного типа был описан: {

- ~ Р.Портером
 - ~ П.Эрлихом
 - ~ К.Пирке
 - = Р.Кохом
 - ~ К.Ландштейнером.
- }

Для синдрома Ди-Джорджи характерны: {

- ~%-50%гломерулонефрит
 - ~%33,33333%гипоплазия тимуса
 - ~%33,33333%аномалии лицевого скелета
 - ~%33,33333%аплазия паращитовидных желез.
 - ~%-50%атопический дерматит.
- }

Сывороточная болезнь была впервые описана: {

- ~ Р.Кумбсом
 - = К.Пирке
 - ~ Ж.Борде
 - ~ Э.Берингом
 - ~ Ф.Бернетом.
- }

Заболевания, развивающиеся по III типу аллергических реакций: {

- ~ бронхиальная астма
 - = системная красная волчанка
 - ~ полиноз
 - ~ тяжёлая миастения
 - ~ анафилактический шок.
- }

Существуют следующие виды нарушения работы иммунной системы: {

- ~%-50%железодефицитная анемия
 - ~%33,33333%избыточная, неадекватная реактивность иммунной системы (аллергия)
 - ~%33,33333%иммунодефицит
 - ~%33,33333%аутоиммунные заболевания
 - ~%-50% инфекционные заболевания.
- }

Вирус Эпштейна-Барр: {

- ~%33,33333%вызывает лимфому Бёркитта
 - ~%33,33333%продуцирует суперантигены
 - ~%33,33333%кофактор тяжёлых реакций на лекарственные средства
 - ~%-50%участвует в анафилактических реакциях
 - ~%-50%участвует в реакциях иммунокомплексного типа.
- }

Отторжение трансплантатов происходит вследствие: {

~%-50%активации тучных клеток

~%33,33333%активации систем свёртывания крови

~%33,33333%антителозависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности

~%33,33333%антителонезависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности

~%-50%развития аллергических реакций.

}

Факторами, повышающими риск отторжения трансплантата, являются: {

~%50%наличие предсуществующих антител после переливания крови

~%50%наличие предсуществующих антител после многократной беременности

~%-33,33333%иммунодефицит

~%-33,33333%применение кортикостероидных препаратов

~%-33,33333%применение антитоксической сыворотки.

}

Синдром Шёгрена может сопровождаться развитием: {

~анемии

~артралгий

~экземы

~бронхиальной астмы

=атрофии слюнных желёз.

}

Возрастные особенности иммунитета в стоматологии обусловлены: {

=морфо-функциональными изменениями в иммунных органах

~беременностью

~менопаузой

~потерей зубов

~аллергическими заболеваниями.

}

Заболевания, чаще развивающиеся при первичных Т-клеточных иммунодефицитах: {

~%50%вирусные

~%50%грибковые

~%-33,33333%протозойные

~%-33,33333%бактериальные

~%-33,33333%глистные инвазии.

}

Риск отторжения трансплантата повышается в случае: {

~%-50%применения иммунодепрессантов

~%-50%применения кортикостероидных препаратов

~%33,33333%пресенсибилизации реципиента к антигенам клеток эндотелия реципиента

~%33,33333%наличия цитотоксических тепловых антител

~%33,33333%снижении дозы иммуносупрессорных препаратов.

}

Для синдрома Вискотта-Олдрича характерны: {
~%33,33333%рецидивирующие инфекции
~%33,33333%тромбоцитопении
~%33,33333%экзема
~%-50%пороки сердца
~%-50%аномалии развития конечностей.
}

Укажите заболевания, возможные в первой стадии инфицирования ВИЧ: {
~%-33,33333%лимфома мозга
~%-33,33333%грибковые поражения кожи и слизистых оболочек
~%50%лимфаденопатия
~%50%рецидивирующая пневмония (более двух эпизодов за 12 месяцев)
~%-33,33333%саркома Капоши.
}

При X-сцепленной агаммаглобулинемии Брутона развиваются инфекционные заболевания {:
~с 1 – 2 месяца жизни
= с 4 – 6 месяца жизни
~на втором году жизни
~в подростковом возрасте
~в разное время.
}

Заболевания, развивающиеся по III типу аллергических реакций: {
~%-33,33333%гемолитическая анемия
~%50%системная красная волчанка
~%50%ревматоидный артрит
~%-33,33333%тяжёлая миастения
~%-33,33333%анафилактический шок.
}

Существуют следующие виды нарушения работы иммунной системы: {
~%-33,33333%заболевания крови
~%50%аллергические заболевания
~%50%аутоиммунные заболевания
~%-33,33333%опухолевые заболевания
~%-33,33333%инфекционные заболевания.
}

Вирус-индуцированными опухолями являются: {
~%-50%рак почки
~%33,33333%лимфома Бёркитта
~%-50% рак желудка
~%33,33333%рак носоглотки
~%33,33333%Т-клеточный лейкоз взрослых.
}

Вирусная теория происхождения злокачественного роста была предложена: {

- ~Э.Берингом
 - =Л.А.Зильбером
 - ~Г.Снеллом
 - ~Ш.Миллером
 - ~С.Тонегава.
- }

Антибластомные клеточные факторы: {

- ~%33,33333%CD-8+ клетки в комплексе с МНС-I
 - ~%33,33333%NK-клетки
 - ~%-50%нейтрофилы
 - ~%-50%эозинофилы
 - ~%33,33333%активированные макрофаги.
- }

К источникам эпидермальных аллергенов относятся: {

- ~%-33,33333%слюна кошки
 - ~%50%шерсть собаки
 - ~%50%перхоть лошади
 - ~%-33,33333%клещи
 - ~%-33,33333%слюна жалящих насекомых.
- }

Заболевания, развивающиеся по II типу аллергических реакций: {

- ~%50%гемолитическая анемия
 - ~%50%тяжёлая миастения
 - ~%-33,33333%атопический дерматит
 - ~%-33,33333%поллиноз
 - ~%-33,33333%системная красная волчанка.
- }

Участие Ig-M в патогенезе аллергических заболеваний: {

- ~%-50%связывание с рецепторами тучных клеток
 - ~%33,33333%развитие аллергических реакций II типа
 - ~%-50%индукция дегрануляции тучных клеток
 - ~%33,33333%формирование иммунных комплексов
 - ~%33,33333%развитие аллергических реакций III типа.
- }

Пломбировочные материалы, соединяясь с белком в пульпе зуба, могут вызвать: {

- ~%33,33333%отёка Квинке
 - ~%33,33333%анафилактического шока
 - ~%33,33333%стоматита
 - ~%-50%поллиноза
 - ~%-50%синдрома Лайелла.
- }

Клинические признаки аллергических реакций на пластмассы, используемые в стоматологии: {

- ~%33,33333%глоссит
 - ~%-50%кариес
 - ~%33,33333%стоматит
 - ~%33,33333%%33,33333%приступы удушья
 - ~%-50%пародонтит.
- }

Кандидоз полости рта может быть следствием: {

- ~%-33,33333%отёка Квинке
 - ~%-33,33333%ангионевротического отёка
 - ~%50%первичного иммунодефицита
 - ~%50%ВИЧ-инфекции
 - ~%-33,33333%местной анестезии.
- }

Наименее аллергенны протезы, изготовленные с применением: {

- ~красителей
 - = фарфора
 - ~нитрита титана
 - ~метакрилата
 - ~никеля.
- }

Новокаин может вызвать перекрёстно-аллергическую реакцию: {

- ~%33,33333%с бензокаином
 - ~%33,33333%лидокаином
 - ~%33,33333%тримекаином
 - ~%-50%нитритом титана
 - ~%-50%антибиотиками .
- }

«Шоковые» органы-мишени аллергических реакций у человека: {

- ~%-33,33333%печень
 - ~%50%бронхи
 - ~%-33,33333%лимфатические узлы
 - ~%50%кожа
 - ~%-33,33333% почки.
- }

Аутоиммунные заболевания протекают в следующей форме: {

- ~%-33,33333%острой
 - ~%50%органоспецифической
 - ~%50%системной
 - ~%-33,33333%фульминантной
 - ~%-33,33333%%33,33333% септической.
- }

Аутоиммунные заболевания преимущественно развиваются: {
=у женщин репродуктивного возраста
~ у мужчин
~ у детей
~у подростков
~вне зависимости от возраста.
}

Синдром Рейтера характеризуется поражением: {
~%33,33333%суставов
~%-50%сердечно-сосудистой системы
~%-50%эндокринной системы
~%33,33333%мочеполовой системы
~%33,33333%поражением глаз.
}

Факторы, способствующие росту опухоли: {
~%33,33333%слабая иммуногенность опухолевых антигенов
~%33,33333%приобретённая резистентность к апоптозу
~%33,33333%экспрессия на поверхности опухолевых клеток рецепторов к ростовым факторам
~%-50%высокая иммуногенность опухолевых антигенов
~%-50%снижение синтеза ИЛ-6, ИЛ-10.
}

Опухоль-ассоциированные антигены: {
~%-33,33333%обнаруживаются только в сыворотке крови
~%-33,33333%экспрессируются на мембранах нормальных клеток
~%-33,33333%презентируются молекулами HLA-II
~%50%презентируются молекулами HLA-I
~%50%могут быть использованы для ранней диагностики.
}

Заболевания, развивающиеся по I типу аллергических реакций: {
~гемолитическая анемия
~контактный дерматит
=поллиноз
~узелковый периартериит
~ тяжёлая миастения.
}

Артюса – это: {
~аллергическая реакция I типа
=аллергическая реакция III типа
~мультисистемный васкулит
~ангионевротический отёк слизистой оболочки полости рта
~крапивница.
}

Ig-G опосредованные аллергические реакции наблюдаются: {
=при сывороточной болезни
~при анафилактическом шоке
~при поллинозе
~бронхиальной астме
~риноконъюнктивите.
}

Рассеянный множественный склероз: {
~%-50%наследуется по доминантному типу
~%33,3333%характеризуется наличием аутореактивных Т-лимфоцитов,
направленных против основного белка миелина
~%33,3333%может развиваться после предшествующих вирусных инфекций
~%-50%чаще болеют мужчины
~%33,3333%чаще болеют женщины.
}

Отторжение трансплантатов происходит вследствие: {
~%-50%активации комплемента иммунными комплексами
~%-50%активации тучных клеток
~%33,3333%атителозависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности
~%33,3333%антителонезависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности
~%33,3333%выработки специфических антител к ткани трансплантата
}

Антибластомные гуморальные факторы: {
~%-50% циркулирующие иммунные комплексы
~%33,3333%фактор некроза опухолей
~%33,3333%интерфероны
~%33,3333% ИЛ-2
~%-50% трансформирующий фактор роста.
}

Возможный вариант развития анафилактического шока: {
~рецидивирующий
~интермиттирующий
~септический
=абортивный
~волнообразный.
}

Среди перечисленных металлов аллергенами не являются: {
~%50%золото
~%50%серебро
~%-33,3333%олово
~%-33,3333%алюминий
~%-33,3333%хром.
}

Медиаторы, участвующие в развитии атопических дерматитов: {

- ~%33,33333%гистамин
 - ~%33,33333%лейкотриены
 - ~%33,33333%простагландины
 - ~%-50%дефензины
 - ~%-50%фибронектин.
- }

В патогенезе развития сывороточной болезни принимают участие: {

- ~антибиотики
 - ~ферменты
 - =гетерологичные сыворотки
 - ~вакцины
 - ~адаптогены.
- }

Перекрёстно-аллергические реакции у больных опосредованы: {

- ~наличием единых региональных условий проживания больных
 - ~генетическими предпосылками в рамках отдельных групп больных
 - ~отсутствием эффекта аллергенспецифической терапии
 - = наличием общих эпитопов в структуре аллергена
 - ~имеют случайный характер.
- }

Иммунологическая толерантность – состояние иммунной системы, развивающееся вследствие: {

- ~%33,33333%отсутствия активации иммунных клеток
 - ~%-50%тяжёлой комбинированной иммунной недостаточности
 - ~%33,33333%отрицательной селекции (делеции) клонов аутореактивных лимфоцитов
 - ~%33,33333%подавления состоявшегося иммунного ответа
 - ~%-50%положительной селекции лимфоцитов.
- }

Иммунологическая толерантность может быть: {

- ~%33,33333% врождённой
 - ~%33,33333%искусственно индуцированной
 - ~%33,33333% результатом супрессии уже состоявшегося иммунного ответа
 - ~%-50%симптомом СПИДа
 - ~%-50%симптомом опухоли вилочковой железы.
- }

Ауто толерантность – это: {

- ~%50%естественная толерантность к собственным тканям
 - ~%-33,33333%толерантность, обусловленная естественной инволюцией тимуса
 - ~%50%толерантность, обусловленная отрицательной селекцией клонов аутореактивных лейкоцитов
 - ~%-33,33333%толерантность, развивающаяся вследствие иммунодефицита
 - ~%-33,33333%толерантность, индуцированная положительной селекцией лимфоцитов.
- }

Антигены приобретают толерогенные свойства: {
~%33,33333% в случаях действия иммуносупрессорных факторов
~%33,33333% при очень небольшой дозе («низкодозная толерантность»)
~%33,33333% при очень большой дозе («высокодозная толерантность»)
~%-50% при развитии вторичного иммунодефицита
~%-50% у больных первичными иммунодефицитами.
}

Феномен иммунологической толерантности был открыт: {
~Ф.Бернетом
=П.Медавара
~Ш.Рише
~Ж.Портье
~С.Снеллом.
}

Отторжение аллотрансплантата может быть вызвано: {
~%33,33333% действием цитотоксических лимфоцитов
~%33,33333% несовместимостью по антигенам МНС
~%33,33333% окклюзией сосудов трансплантата
~%-50% активацией тучных клеток
~%-50% применением антибиотиков
}

Профилактика отторжения аллотрансплантата: {
~%33,33333% подбор методом генотипирования
~%33,33333% введение иммунодепрессантов
~%33,33333% совместимость по антигенам МНС
~%-50% введение антитоксической сыворотки
~%-50% введение иммуностимуляторов.
}

Нарушение толерантности к собственным тканям приводит: {
~%-33,33333% к неустойчивости к инфекционным заболеваниям
~%50% к развитию аутоиммунных заболеваний
~%50% к нарушению репродуктивной функции
~%-33,33333% к развитию аллергических заболеваний
~%-33,33333% к развитию опухолевых заболеваний.
}

Свойствами толерогенов обладают: {
=малые дозы высокомолекулярных антигенов
~суперантигены
~высокие дозы концентрированных антигенов
~перекрёстно-реагирующие антигены
~экзотоксины.
}

Диагностические критерии ревматоидного артрита: {
~%33,33333%поражение симметричных периферических суставов
~%-50%миокардит
~%33,33333%симптом «утренней скованности»
~%33,33333%наличие ревматоидного фактора
~%-50%уртикарные кожные высыпания.
}

Характерные клинические признаки геморрагического васкулита: {
~%50%кожные высыпания
~%-33,33333%полиартрит
~%50%геморрагическая пневмония
~%-33,33333%гломерулонефрит
~%-33,33333%стоматит.
}

К системным аутоиммунным заболеваниям относят: {
~%33,33333%красную волчанку
~%33,33333%рассеянный склероз
~%-50%болезнь Хашимото
~%33,33333%ревматоидный полиартрит
~%-50%болезнь Грейвса.
}

Гиперчувствительность замедленного типа по классификации Джелла и Кумбса – это аллергическая реакция: {
~I-го типа
~II-го типа
~III-го типа
~IV-типа (клеточного)
~V-го типа.
}

Анафилактогенная активность аллергена не проявляется при попадании в организм: {
~через раневую поверхность
~ингаляционным путём
~при внутрикожном введении
~энтеральным путём
~в количестве, меньше разрешающей дозы.
}

Фазы аллергических реакций: {
~ %33,33333%иммунологическая
~%-50%биохимическая
~%33,33333%патохимическая
~%-50%цитотоксическая
~%33,33333%патофизиологическая.
}

Гранулы тучных клеток человека содержат: {
~%33,33333%гистамин
~%33,33333%триптазы
~%33,33333%гепарин
~%-50%бета-лизины
~%-50%интерфероны.
}

Тучные клетки человека находятся: {
~в крови
~в лимфе
~в селезёнке
~в лимфоузлах
=в коже.
}

Тучные клетки человека могут выделять: {
~%50%гистамин
~%50%гепарин
~%-33,33333%перфорин
~%-33,33333%гранзимы
~%-33,33333%N-ацетилмурамидазу.
}

Дегрануляция тучных клеток происходит в течение: {
=20-30 секунд
~одного часа
~ нескольких часов
~12 часов
~в разные сроки.
}

Ig G-опосредованные аллергические реакции наблюдаются при: {
~поллинозе
~атопическом дерматите
=сывороточной болезни
~отёке Квинке
~бронхиальной астме.
}

Болезнь Грейвса-Базедова: {
~%33,33333% обусловлена выработкой антител к мембранному рецептору тиреотропного гормона
~%33,33333% относится к V типу аллергических реакций
~%33,33333% характеризуется гиперпродукцией тироксина
~%-50% аутоантигеном является тиреоглобулин
~%-50%характеризуется признаками гипотиреоза
}

Активация системы комплемента при сывороточной болезни происходит вследствие: {
~высвобождения ацетилхолина
=образования иммунных комплексов
~прекращения контакта с аллергеном
~проведения аллерген-специфической иммунотерапии
~применения кортикостероидных гормонов.
}

Первый тип аллергических реакций развивается при: {
~%33,33333%поллинозе
~%-50%гемолитической анемии
~%33,33333%анафилактическом шоке
~%33,33333%атопическом дерматите
~%-50%сывороточной болезни.
}

Лекарственная аллергия проявляется развитием: {
~%-33,33333%ревматического артрита
~%-33,33333%ангионевротического отёка
~%50%гемолитической анемии
~%50%синдрома Лайелла
~%-33,33333%узелкового периартериита.
}

Ангионевротический отёк: {
~%33,33333%развивается при дефиците системы комплемента
~%33,33333%сопровождается отёком подкожных и подслизистых тканей
~%33,33333%может сочетаться с крапивницей
~%-50%может сопровождаться атопическими реакциями
~%-50%развивается при дефиците системы фагоцитоза.
}

Для синдрома Ди-Джорджи характерны: {
~%-50%атопические реакции
~%-50%сочетается с синдромом Лайелла
~%33,33333%гипоплазия тимуса
~%33,33333%аномалии лицевого скелета
~%33,33333%аплазия паращитовидных желёз.
}

Свойства антигенов вирус-индуцированных опухолей: {
~%-33,33333%отличаются во всех опухолях и тканях в зависимости от их гистогенеза
~%-33,33333%могут быть внутриклеточными
~%50%могут экспрессироваться на мембранах клеток опухоли
~%50%идентичны во всех опухолях
~%-33,33333%изменяются в процессе роста опухоли.
}

Раково-эмбриональными антигенами являются: {
~%-33,33333%простатспецифический антиген (PSA)
~%50%альфа –фетопротеин
~%50%бета-хорионический гонадотропин
~%-33,33333%белок Р-53
~%-33,33333%антиген HBS.
}

Аутоиммунными заболеваниями чаще страдают: {
~подростки
=женщины репродуктивного возраста
~зависит от расовой принадлежности
~новорождённые
~лица, страдающие иммунодефицитами.
}

Вирус-индуцированными опухолями являются: {
~ рак предстательной железы
= лимфома Беркитта
~ рак молочной железы
~ рак поджелудочной железы
~ рак яичника.
}

Вирусная теория происхождения злокачественного роста была предложена: {
~ Э.Берингом
= Л.Зильбером
~ Г.Снеллом
~ Ш.Миллером
~ С.Тонегава.
}

Антибластомные клеточные факторы: {
= CD-8+ клетки в комплексе с МНС-I
~ ИЛ- 2
~ ИЛ-6
~ трансформирующий фактор роста
~ простагландины.
}

К источникам эпидермальных аллергенов относятся: {
~ слюна кошки
~ споры грибов
= перхоть лошади
~ клещи
~ слюна жалящих насекомых.
}

Заболевания, развивающиеся по II типу аллергических реакций: {
= гемолитическая болезнь новорождённых
~ сахарный диабет
~ крапивница
~ поллиноз
~ системная красная волчанка.
}

«Шоковые» органы-мишени аллергических реакций у человека: {
~ печень
~ селезёнка
~ лимфатические узлы
= кожа
~ почки.
}

Аутоиммунные заболевания протекают в следующей форме: {
~ острой
= органоспецифической
~ септикопиемической
~ фульминантной
~ септической.
}

Синдром Рейтера характеризуется поражением: {
~ печени
~ сердечно-сосудистой системы
~ эндокринной системы
= мочеполовой системы
~ поджелудочной железы.
}

Факторы иммунорезистентности опухоли: {
~%33,33333%слабая иммуногенность опухолевых антигенов
~%33,33333%постоянная модификация антигенов
~%33,33333%появление на мембране Fas-L
~%-50% активация NK-клеток
~%-50% фактор некроза опухоли
}

Опухоль-ассоциированные антигены: {
~ обнаруживаются только в сыворотке крови
~ экспрессируются на мембранах нормальных клеток
= презентирются молекулами HLA-I класса
~ презентирются молекулами HLA-II класса
~ обладают высокой иммуногенностью.
}

Заболевания, развивающиеся по I типу аллергических реакций: {

- ~ гемолитическая анемия
 - ~ контактный дерматит
 - = поллиноз
 - ~ узелковый периартериит
 - ~ тяжёлая миастения.
- }

Феномен Артюса – это {:

- = вторичное повреждение тканей ферментами лизосом
 - ~ аллергическая реакция на пыльцу растений
 - ~ гнойно-некротическое поражение подкожной клетчатки
 - ~ ангионевротический отёк слизистой оболочки полости рта
 - ~ уртикарные высыпания в эпидермисе.
- }

Ig-G опосредованные аллергические реакции наблюдаются: {

- = при системной красной волчанке
 - ~ при анафилактическом шоке
 - ~ при отёке Квинке
 - ~ при риноконъюнктивите
 - ~ при бронхиальной астме.
- }

Диагностические признаки аутоиммунных заболеваний: {

- ~%33,33333%наличие специфических аутоантител
 - ~%33,33333%образование комплексов IgM/IgG1-3
 - ~%50%рецидивирующие гнойничковые заболевания
 - ~%33,33333%повышение количества аутореактивных лимфоцитов
 - ~%50% анафилактические реакции.
- }

Рассеянный множественный склероз: {

- ~%33,33333%характеризуется прогрессирующим течением
 - ~%33,33333%характеризуется наличием аутореактивных Т-лимфоцитов, направленных против основного белка миелина
 - ~%33,33333%может развиваться против предшествующих вирусных инфекций
 - ~%-50%чаще дебютирует в пожилом возрасте
 - ~%-50%является аллергической реакцией IV типа.
- }

Отторжение трансплантатов происходит вследствие: {

- ~%-50% применения антибиотиков
 - ~%33,33333%активации систем свёртывания крови
 - ~%33,33333%антителозависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности
 - ~%33,33333%антителонезависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности
 - ~%-50%назначения высоких доз иммунодепрессантов .
- }

Антибластомные гуморальные факторы: {
~ ИЛ-2
= фактор некроза опухолей
~ β -дефензины
~ ИЛ-6
~ N-ацетилмурамидаза.
}

В развитии атопических дерматитов участвуют: {
= гистамин
~ лизоцим
~ комплемент
~ перфорин
~ Ig-M.
}

В патогенезе сывороточной болезни принимают участие: {
~ антибиотики
~ ферменты
= гетерологичные иммуноглобулины
~ вакцины
~ интерфероны.
}

Перекрёстно-аллергические реакции у больных опосредованы: {
~ наличием единых региональных условий проживания больных
~ генетическими предпосылками в рамках отдельных групп больных
~ отсутствием эффекта аллергенспецифической терапии
= наличием общих эпитопов в структуре аллергена
~ имеют случайный характер.
}

Иммунологическая толерантность – состояние иммунной системы, развивающееся вследствие: {
~ отсутствия активации антигенпредставляющих клеток
~ тяжёлой комбинированной иммунной недостаточности
= отрицательной селекции (делеции) клонов аутореактивных лимфоцитов
~ применения адъювантов
~ положительной селекции лимфоцитов в тимусе.
}

Иммунологическая толерантность может быть: {
~ результатом применения вакцинных препаратов
= искусственно индуцированной
~ результатом инволюции костного мозга
~ симптомом СПИДа
~ симптомом опухоли вилочковой железы.
}

Аутоотолерантность – это: {

= естественная толерантность к собственным антигенам

~ толерантность, обусловленная естественной инволюцией тимуса

~ толерантность, обусловленная положительной селекцией клонов лимфоцитов

~ толерантность, развивающаяся вследствие иммунодефицита

~ толерантность к антигенам, индуцированная цитостатиками.

}

Феномен иммунологической толерантности был открыт и изучен: {

~ Ф.Бернетом

= П.Медаваром

~ Ш.Рише

~ Ж.Портье

~ С.Снеллом.

}

Нарушение толерантности к собственным тканям приводит: {

~ к неустойчивости к инфекционным заболеваниям

= к развитию аутоиммунных заболеваний

~ к нарушению работы нервной системы

~ к развитию аллергических заболеваний

~ к развитию опухолевых заболеваний.

}

К аутоиммунным заболеваниям относят: {

~%33,33333%синдром Чёрджа-Стокса

~%-50%синдром Лайелла

~%33,33333%узелковый периартериит

~%33,33333%синдром Шёгрена

~%-50%синдром Стивена-Джонсона

}

Синдром Лайелла характеризуется: {

~%33,33333%лихорадочной реакцией

~%33,33333%отслаиванием эпидермиса

~%33,33333%поражением глаз

~%-50%развивается после назначения иммунодепрессантов

~%-50%развитием пневмонии.

}

Свойствами толерогенов обладают: {

= малые дозы высокомогенов антигенов

~ суперантигены

~ гетерогенные антигены

~ перекрёстно-реагирующие антигены

~ экзотоксины.

}

Гиперчувствительность замедленного типа по классификации

Джелла и Кумбса – это аллергическая реакция: {

~ I-го типа

- ~ II-го типа
 - ~ III-го типа
 - = IV-типа
 - ~ V- типа.
- }

Анафилактическая активность аллергена не проявляется при попадании в организм: {

- ~ в первый раз
- ~ ингаляционным путём
- ~ при внутрикожном введении
- ~ энтеральным путём

= в количестве, меньше разрешающей дозы.

}

Фазы аллергических реакций: {

- ~ иммуногенная
- ~ биохимическая

= патохимическая

- ~ цитотоксическая
- ~ патогенная.

}

Тучные клетки человека находятся в большом количестве: {

- ~ в крови
- ~ в лимфе
- ~ в аппендиксе
- ~ в лимфоузлах

= в коже.

}

Гранулы тучных клеток человека могут выделять: {

= гистамин

- ~ фибронектин
- ~ перфорин
- ~ β -лизины
- ~ N-ацетилмурамидазу.

}

При I типе аллергических реакций осуществляется: {

- ~ активация антителозависимого цитолиза
- ~ выработка цитотоксических антител

= высвобождение вазоактивных аминов

- ~ активация Т-киллеров
- ~ образование иммунных комплексов.

}

Адоптивный перенос состояния иммунитета осуществляется с помощью: {

- ~ переливания цельной крови
- ~ антител

- ~ иммуномодуляторов
- = иммунокомпетентных клеток
- ~ моноклональных антител .

}

Дегрануляция тучных клеток происходит в течение: {

- = 20-30 секунд
- ~ одного часа
- ~ нескольких часов
- ~ 12 часов
- ~ в зависимости от дозы аллергена.

}

Активация системы комплемента при сывороточной болезни происходит вследствие: {

- ~ высвобождения ацетилхолина
- = образования иммунных комплексов
- ~ прекращения контакта с аллергеном
- ~ проведения аллерген-специфической иммунотерапии
- ~ применения антилимфоцитарной сыворотки.

}

Уровень Ig E в сыворотке крови повышается при: {

- ~ системной красной волчанке
- = атопическом дерматите
- ~ гемолитической болезни
- ~ миастении
- ~ сывороточной болезни .

}

Вакцина – это: {

- ~ антитоксическая сыворотка
- ~ антитела
- = убитая или ослабленная культура микроорганизмов
- ~ иммунная сыворотка
- ~ экзотоксин.

}

Инфекции способны инициировать аутоиммунный процесс вследствие: {

- ~ отсутствия иммунопрофилактики
- = перекрёстных реакций с аутоантигенами
- ~ наличия у возбудителя неполноценных антигенов
- ~ частого обострения инфекций
- ~ отсутствия антибиотикотерапии.

}

Отторжение аллотрансплантата может быть обусловлено: {

- ~%33,33333%действием цитотоксических лимфоцитов
- ~%33,33333%несовместимостью по антигенам МНС

~%33,3333%окклюзией сосудов трансплантата
~%-50%вирусной инфекцией
~%-50%формированием анафилактической реакции на лекарственные препараты.
}

Профилактика отторжения аллотрансплантата: {
~ использование адаптогенов
= использование иммунодепрессантов
~ использование моноклональных антител
~ введение антиглобулиновой сыворотки
~ введение иммуностимуляторов.
}

Внутрикожные аллергические пробы применяются для диагностики: {
~ сальмонеллёза
~ чумы
~ кампилобактериоза
= бруцеллёза
~ краснухи.
}

Лабораторные диагностические критерии ревматоидного артрита: {
~ снижение уровня гемоглобина
~ снижение иммунорегуляторного индекса
~ тромбоцитопения
= наличие аутоантител к кератогиалиновым гранулам эпителия слизистой оболочки полости рта
~ лимфоцитоз.
}

Серотонин при атопических реакциях выделяют: {
~ гранулы тучных клеток
= тромбоциты
~ нейтрофильные лейкоциты
~ эозинофилы
~ эритроциты,
}

Кожные тесты с аллергенами проводят: {
~ на наружной поверхности предплечья
~ на внутренней поверхности плеча
= на внутренней поверхности предплечья
~ на спине
~ на боковой поверхности живота.
}

При участии каких механизмов развиваются аллергические реакции III типа: {
= комплемент-зависимого цитолиза
~ дегрануляции тучных клеток

- ~ клеточно-опосредованной реакции
- ~ повышении уровня Ig-E
- ~ перекрёстно-аллергических реакций.

}

У человека наиболее богаты тучными клетками: {

- ~ пищеварительный тракт
- ~ периферическая кровь
- = кожа
- ~ паренхима печени
- ~ нервная ткань.

}

В развитии клеточной реакции иммунного воспаления не участвуют: {

- = стволовые
- ~ тромбоциты
- ~ макрофаги
- ~ эозинофилы
- ~ тучные клетки.

}

Роль наследственного фактора в аллергических заболеваниях: {

- ~ наследуется конкретное аллергическое заболевание
- = передаётся предрасположенность к аллергии
- ~ не играет никакой роли
- ~ наследуется по доминантному типу
- ~ неверно всё перечисленное.

}

Стимуляция специфически сенсibilизированной тучной клетки приводит к высвобождению: {

- ~ ацетилхолина
- = тромбоцитарного фактора (ТАФ)
- ~ адреналина
- ~ перфорины
- ~ лизоцима.

}

В развитии гиперчувствительности I типа участвуют: {

- ~ Ig-A
- ~ Ig-M
- ~ Ig-G
- = Ig-E
- ~ Ig-D.

}

Перед постановкой проб с неинфекционными аллергенами кожа обрабатывается: {

- ~ раствором эфира
- ~ кипячёной водой

~ раствором перекиси водорода
= 70% спиртом
~ достаточно вымыть водой и мылом.
}

Свойства иммуноглобулинов класса E: {
~ пентамеры
= участвуют в развитии реакций гиперчувствительности I типа
~ проходят через плаценту
~ обеспечивают местный иммунитет
~ обладают высокой авидностью.
}

Гистамин относится: {
= к азотистым основаниям
~ к монокинам
~ к лейкотриенам
~ к простагландинам
~ к гранзимам.
}

Поздняя фаза аллергических реакций обусловлена активностью: {
~ эритроцитов
~ тромбоцитов
~ нейтрофилов
~ базофилов
= макрофагов.
}

Среди FcεR различают: {
~ нейтральные по аффинности
= высокоаффинные
~ неспецифичные
~ с низкой аффинностью
~ ареактивные.
}

К реакциям гиперчувствительности немедленного типа относятся: {
~ инфекционная аллергия
~ иммунокомплексная реакция
= атопии
~ цитоллиз с участием комплемента
~ феномен Артюса.
}

В синтезе Ig-E участвуют: {
~ макрофаги
~ эозинофилы

- ~ НК-клетки
- ~ Т-лимфоциты
- = В-лимфоциты.

}

Рецепторы для Ig-E экспрессируются на мембране: {

- ~ клеток микроглии
- = тучных клеток
- ~ Т- лимфоцитов
- ~ дендритных клеток
- ~ НК-клеток.

}

Для проверки реактивности кожи при аллергическом тестировании используют раствор гистамина следующей концентрации: {

- ~ 0,1%
- = 0,0001%
- ~ 1%
- ~ 0,01%
- ~ 2%.

}

Положительной считается внутрикожная проба: {

- = при образовании волдыря диаметром 9-15 мм и гиперемии
- ~ при размере реакции, как в контроле
- ~ при образовании волдыря диаметром 20 мм и гиперемии
- ~ при появлении пузыря с серозным содержимым и гиперемии
- ~ при появлении пузыря с геморрагическим содержимым и гиперемии.

}

Гиперчувствительность замедленного типа – это: {

- ~ анафилактическая реакция
- ~ цитотоксическая реакция
- = Т-зависимая аллергическая реакция
- ~ реакция отложения иммунных комплексов
- ~ псевдоаллергическая реакция.

}

К реакциям гиперчувствительности IV типа относятся: {

- = инфекционная аллергия
- ~ иммунокомплексные аллергические реакции
- ~ атопическая бронхиальная астма
- ~ анафилактический шок
- ~ сывороточная болезнь.

}

Патофизиологическая стадия аллергических реакций I типа характеризуется: {

- ~ повышением артериального давления
- ~ формированием иммунных комплексов

= повышением образования вязкого секрета слизистых оболочек
~ появлением гнойного отделяемого
~ появлением гемморрагических высыпаний на коже.
}

При развитии псевдоаллергической реакции отсутствует: {
~ патохимическая фаза
~ патофизиологическая
= иммунологическая
~ иммуногенная
~ патогенная.
}

Системные аллергические реакции на лекарственные средства включают: {
~ септическую лихорадку
~ ангионевротический отёк
~ синдром Шёгрена
= синдром Лайелла
~ болезнь Бехчета.
}

К гиперчувствительности I типа относятся реакции: {
~ цитотоксические
~ иммунокомплексные
= анафилактические
~ клеточные
~ гемолитические.
}

«Клетки-мишени» аллергических реакций имеющие высокоаффинные FcεR: {
= тучные клетки
~ дендритные клетки
~ купферовские клетки
~ NK- клетки
~ нейтрофилы.
}

При каком поступлении аллергена в организм наиболее вероятно формирование поллиноза: {
~ внутривенном
= ингаляционном
~ подкожном
~ энтеральном
~ внутримышечном.
}

Основной морфологический элемент крапивницы: {
~ папула
~ везикула

- = волдырь
- ~ энантема
- ~ геморрагическая сыпь.
- }

Наиболее аллергенна пыльца: {

- ~ растений, опыляемых насекомыми

= ветроопыляемых растений

- ~ искусственно опыляемых растений
- ~ комнатных растений
- ~ злаковых растений.

}

Нарушения в дыхательной системе при анафилактическом шоке: {

- = бронхоспазм
- ~ кашель
- ~ пневмония
- ~ застойные явления в малом круге кровообращения
- ~ лёгочное кровотечение.

}

Истинными аллергенами, вызывающими сезонный аллергический ринит являются: {

- =пыльца растений
- ~ пневмококки
- ~ морепродукты
- ~ вирусы гриппа
- ~ пух перелётных птиц.

}

Лечение сывороточной болезни проводится: {

- ~ антибиотиками
- ~ сульфаниламидными препаратами
- ~ ферментами

= антигистаминными препаратами

- ~ дезрастворами (местное лечение).

}

Развитие сывороточной болезни вызывают: {

- ~ пищеварительные ферменты
- ~ пенициллин
- ~ молочные продукты
- ~ сыры

= препараты крови.

}

В аллергических реакциях II типа участвуют: {

- ~ Ig-E антитела

= Ig-G антитела

- ~ Т-лимфоциты
- ~ Ig-A антитела
- ~ купферовские клетки.

}

У больных поллинозом часто выявляется перекрёстная аллергия: {

- ~ к антибиотикам
- ~ к сыру
- = к фитопрепаратам
- ~ к молоку
- ~ к морепродуктам.

}

Наиболее благоприятный вариант течения анафилактического шока {:

- ~ затяжной
- ~ молниеносный
- ~ рецидивирующий
- = абортный
- ~ неверно всё перечисленное.

}

Заболевания, для профилактики которых используют живую вакцину: {

- ~ дифтерия
- ~ брюшной тиф
- = корь
- ~ коклюш
- ~ гепатит А.

}

К аллергенам не относят: {

- ~ яд пчелы
- ~ метаболиты насекомых
- ~ споры плесневых грибов
- ~ пыльцу деревьев
- = золото.

}

Формирование ангионевротического отёка происходит: {

- ~ в эпидермисе
- ~ в нервной ткани
- = в подслизистой ткани
- ~ в мышечной ткани
- ~ только в слизистой ткани.

}